Doutiva — Síntese estratégica

A esco

Documento para análise externa (Claude / conselho)
7 de novembro de 2026 · rev. cérebro vivo / recuperar-ou-criar
Discussões Juliano Brites Cortes × Cursor Agent

1. Problema que estamos resolvendo

Médicos em prática (emagrecimento, performance, alta complexidade ambulatorial) precisam de educação médica continuada, mas:

- não gostam de *estudar* (assistir, ler, decorar);
- gostam de *aprender* (decidir, errar, corrigir, aplicar na segunda-feira);
- já sabem parte do conteúdo — empurrar curso linear gera tédio e abandono;
- precisam de proximidade (turma, mentor, eventos), não só de app;
- a escola também precisa ajudar o médico a gerar demanda no consultório (protocolo → público → agenda);
- a escola precisa ser comunidade: médicos que ensinam (aulas próprias) e mentoram, e alunos que contratam essa proximidade — com a Doutiva no meio (take rate).

A Doutiva não pode ser “mais um LMS com IA”. Tem que ser a escola do médico do futuro: um cérebro vivo no meio do negócio — entende a necessidade, usa o que já existe, cria o que não existe (com curadoria), popula a plataforma, indica mentor, e aproxima a comunidade.

2. Frase-mestra (para não se perder)

A IA descobre o buraco. Se já tem aula/curso, usa. Se não tem, cria (com curadoria) e grava no banco para o próximo. O Caso do Dia vira hábito. Mentores + eventos criam a comunidade. A IA também indica o mentor certo.

Versão curta:

Diagnóstico → recuperar ou criar → hábito → profundidade → mentor/evento. O cérebro no meio; o banco cresce com cada necessidade atendida.

3. Quatro promessas, um sistema

Promessa | Para quem | Resultado

— Aprender sem sofrer · O médico aluno · Só estuda o que falta; sessões curtas; domínio medido

— Protocolo que gera demanda · O consultório do aluno · Conduta padronizada → oferta clara ao paciente → agenda

— Comunidade que gera renda · O médico mentor · Aulas próprias + mentoria direta → take rate Doutiva

— Escola que se popula · A própria Doutiva · Cada gap atendido vira patrimônio reutilizável no banco

Se só educar → vira curso. Se só “gerar demanda” → vira marketing. Se só marketplace → vira iFood de mentor sem escola. Se só gerar aula sem curadoria → vira lixo infinito. A Doutiva junta: domínio → conduta → clínica, comunidade de mentores, e um cérebro que recupera ou cria —

com curadoria — para a escola crescer com a demanda real.

4. Arquitetura de produto (5 peças)

4.1 Caso do Dia = o “Duolingo” clínico

- Unidade: 1 decisão / dia, 3–5 minutos.
- Canal preferencial: WhatsApp primeiro; site para aprofundar.
- Conduta + confiança declarada (`sei / acho / não sei`).
- Alimenta revisão espaçada e o mapa de domínio.
- Não é o mentor quem faz o papel de Duolingo (mentor é caro demais para hábito diário).

4.2 Universidade / Protocolos = curso de verdade

- Tratado, evidência, regulação BR (ANVISA/CFM), guia de bolso.
- Deixa de ser ementa fixa “aula 1, 2, 3…” e vira fila do que falta.
- Aprofundar sob demanda (AMBOSS-like), não parágrafo infinito.
- Oferta comercial: Protocolos R$ 297/mês (+ Peptídeos free como porta).
- Conteúdo oficial Doutiva e aulas gravadas de médicos da comunidade (ver 4.3).

4.3 Mentores = comunidade + marketplace (peça estratégica)

Este é o elemento que fecha a escola numa comunidade pungente, não num LMS frio.

Quem é o mentor na Doutiva

- Médico com aulas próprias dentro da plataforma (gravadas / trilhas assinadas).
- O mesmo médico aparece na vitrine de mentores para contratação direta de mentoria 1:1 ou em turma pequena.
- Não é “palestrante convidado”: é docente + mentor com perfil, agenda e preço.

Economia

- Aluno contrata a mentoria do médico direto na Doutiva.
- Doutiva recebe take rate sobre essa contratação (marketplace desenhado).
- Aulas do mentor alimentam o corpus / vitrine; mentoria paga a proximidade humana.

Papel da IA aqui

- Com o mapa de domínio do aluno, a IA indica o mentor mais adequado (especialidade, temas vermelhos, estilo, disponibilidade).
- Ex.: “Seu buraco está em peptídeos + composição corporal → estes 3 mentores têm aulas e vagas nessa faixa.”
- A IA pensa a trilha e a ponte humana — não substitui o mentor; faz o match.

Por que isso importa

- Sem mentores com pele no jogo, não há comunidade — só conteúdo.
- Com mentores ganhando (aulas + mentoria), a comunidade se autoalimenta: quem ensina atrai quem aprende; quem aprende vira candidato a ensinar.
- Eventos presenciais viram o ápice dessa rede, não o único momento de proximidade.

4.4 Mentoria como produto (SKU separado do hábito)

- Turmas pequenas (8–10) ou 1:1, mentor-guia (não palestrante).
- Encontro curto para discutir os casos mais errados / temas vermelhos do mapa.
- SKU próprio na escada (não misturar com o Caso do Dia).
- Pode ser oferta Doutiva (turma oficial) ou oferta do mentor (marketplace com take rate).

4.5 Eventos presenciais = segundo pilar de proximidade

- Semana Doutiva / A Origem / imersões.
- Marca, networking, confiança Medway-like (“quem assina”).
- Mentores da plataforma sobem ao palco / mesa — a comunidade online vira presença.

---

5. A peça que faltava: ensinar só o que o médico não sabe

Hoje a plataforma ainda empurra curso e caso editorial. Os precursores de sucesso (Alpha School / MathAcademy / Khanmigo / Brilliant) fazem o oposto: diagnosticam o que já sabe e só ensinam o buraco.

5.1 Por que casos fixos sozinhos não bastam

Montar à mão milhares de casos de diagnóstico não escala e continua sendo “nossa trilha”, não “a trilha dele”.

5.2 Direção desejada: IA entrevista e monta a trilha

- IA conduz entrevista socrática (10–15 min).
- Médico responde + declara confiança.
- IA não entrega a conduta — cobra raciocínio (guarda-corpo Khanmigo).
- IA ancora no corpus Doutiva (conteúdo curado), não no ChatGPT genérico.
- Saída: mapa verde / amarelo / vermelho por tema.
- IA sugere/gera a próxima micro-sessão e o Caso do Dia a partir do buraco.
- Material permanente novo passa por assinatura humana (nome + CRM).

5.4 O cérebro vivo: recuperar → criar → persistir → reutilizar

Pode ser que o médico tenha uma necessidade que ainda não existe nas aulas/cursos da plataforma. Aí o cérebro não pode travar nem inventar no vazio a cada vez.

Loop de decisão (núcleo do “ser vivo”)

- Entende a necessidade (mapa / entrevista / Caso do Dia).
- Busca no banco: curso, monografia, aula de mentor, caso já gerado.
- Se existe → monta a trilha com o que há (reuso).
- Se não existe → Estúdio cria aula / microcurso / sessão específica para aquele buraco.
- Persiste no banco (marcada, versionada, ligada ao tema/necessidade).
- O próximo médico com a mesma necessidade recebe o material já criado — a plataforma se popula com a demanda real.
- Curadoria freia a fábrica: não cria qualquer coisa a toda hora.

Regras de curadoria (para não virar lixo)

- Rascunho IA vs. publicado (só publicado entra na trilha de outros alunos).
- Limiar de demanda: ex. N médicos com o mesmo buraco ou criticidade clínica alta → prioriza criação.
- Deduplicação: antes de criar, busca similaridade no corpus.
- Assinatura humana (nome + CRM) para material que vira “curso permanente”.
- Micro-sessão efêmera (só para aquele aluno) vs. aula canônica (vira patrimônio da escola).
- Fila de revisão humana / mentor especialista quando o tema é sensível (regulação, off-label, procedimento).

Isso é o que transforma a Doutiva de “catálogo estático” em organismo que aprende com a demanda dos médicos.

5.3 Regra de avanço (motor de maestria)

Resultado | Ação da plataforma

— Acertou + “sei” · Pula teoria daquele tema

— Acertou + “acho” · Caso gêmeo leve; domínio parcial

— Errou ou “não sei” · Sessão curta só do buraco → reteste

— 3 casos não vistos corretos + confiantes · Tema = dominado

O Índice de Domínio substitui “aula concluída” em painel, certificado e ranking.

---

6. A IA no centro (cérebro único, cinco faces)

Não é um botão “Tutor” no canto. É o ser vivo no meio do negócio — o sistema nervoso da escola.

Face | Função | Entrada → Saída

— Cartógrafo · Entende o médico · Conversa + confiança → mapa de domínio

— Preceptor · Ensina o buraco · Mapa → Caso do Dia / sessão socrática

— Bibliotecário · Recupera o que já existe · Necessidade → busca no corpus / aulas / casos

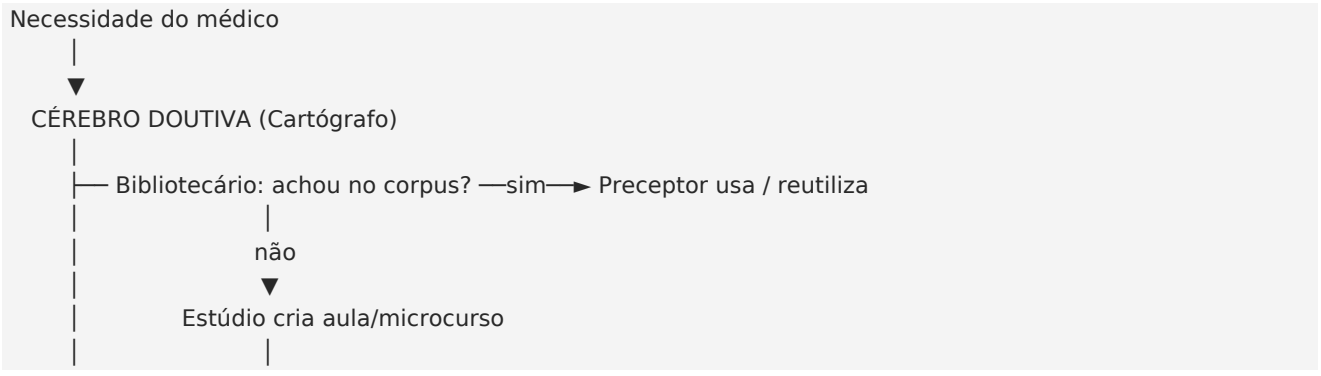
— Estúdio · Cria o que não existe · Gap sem material → aula/microcurso → DB (com curadoria)

— Matchmaker · Indica o mentor certo · Mapa + perfil mentores → ranking de mentores / aulas / vagas

Requisitos para resultado de alto nível

- Memória longa do médico (mastery persistido).
- RAG / corpus Doutiva — só gera e ensina ancorado no material revisado (oficial + aulas de mentores + aulas geradas publicadas).
- Motor recuperar-ou-criar — busca primeiro; só cria se faltar; persiste; reutiliza.
- Curadoria — rascunho ≠ publicado; limiar de demanda; dedupe; assinatura humana.
- Motor de decisão — atualiza mapa → escolhe próxima sessão → agenda revisão.
- Guarda-corpo pedagógico — socrático; nunca entrega conduta antes do compromisso.
- Humano na vitrine — IA na cozinha; CRM/nome na assinatura; mentor/evento na proximidade.
- Match humano — quando o buraco pede pele e voz, a IA aponta o mentor; a contratação passa pelo marketplace (take rate).
- Métricas de verdade — delta de domínio, sessões/semana, retenção D30, NPS, GMV mentoria + take rate, % gaps cobertos por reuso vs. criação nova, tempo até publicar aula canônica.

Arquitetura lógica



```
      │            curadoria + assinatura humana
      │                    │
      │            persiste no DB → vira patrimônio
      │                    │
      └── Matchmaker → mentor / marketplace (take rate)
```

No produto: Professores, Tutor, Caso do Dia, onboarding “Mapa”, Estúdio e Mentores chamam o mesmo cérebro (tools: getMastery, updateMastery, nextSession, retrieveCorpus, createLessonIfMissing, generateLessonDraft, publishLesson, matchMentor).---

7. O que já existe vs. o que falta

Já existe (não jogar fora)

- Loop lâminas → chaves → caso → revisão
- 7 trilhas / conteúdo clínico denso
- Professores de IA (personas) + Tutor
- Revisão espaçada
- Protocolos R$ 297 alinhado na oferta
- Intensidade Completa / Equilibrada / Discreta
- Sprint recente: monografias legíveis, leaks, auto-matrícula, tabs Aprofundar

Falta (o salto)

- IA ligada em produção (env Vercel)
- Entrevista/Mapa clínico como porta de entrada
- Caso do Dia dirigido pelo mapa (não por calendário fixo)
- Índice de Domínio por tema
- WhatsApp como canal do hábito
- Docente com nome/CRM/foto na vitrine
- Vitrine de mentores (perfil, aulas gravadas, agenda, preço)
- Marketplace de mentoria com take rate Doutiva
- Matchmaker IA: mapa do aluno → mentor / aula sugerida
- Bibliotecário + Estúdio vivo: recuperar-ou-criar + persistir no DB
- Fila de curadoria (rascunho → revisão humana → publicado)
- Deduplicação / limiar de demanda para não poluir o catálogo
- Mentor + eventos usando o mapa da turma
- Elo explícito “tema dominado → oferta ao paciente / demanda”
- Loop de comunidade: aluno → mentor → aulas → novos alunos
- Loop de conteúdo: necessidade → gap → criação → reuso pelo próximo

---

8. Plano em fases (ordem prática)

Fase A — Ligar a base (esta semana)

- `OPENAI_API_KEY` (+ Supabase service role) na Vercel + redeploy
- Conta aluno de QA (sem admin)
- Docente real no “Revisado por”
- Limpar fixtures de teste

Fase B — Cérebro + hábito (diferencial)

- Serviço único Cérebro Doutiva
- Fluxo Mapa clínico (entrevista IA → mastery_by_topic)
- Caso do Dia lê a fila do mapa + confiança
- WhatsApp do Caso do Dia (piloto 50)

Fase C — Protocolo + cérebro que popula a escola

- Cada tema dominado desbloqueia Guia de bolso + oferta ao paciente
- Universidade vira fila do que falta (Aula 2.0: caso primeiro)
- Loop recuperar-ou-criar: gap → Estúdio → DB → reuso
- Fila de curadoria + assinatura humana para aulas canônicas

Fase D — Proximidade + comunidade de mentores

- Mentoria (turma Doutiva ou 1:1) com pauta = lacunas do mapa
- Onboard dos primeiros mentores: perfil + aulas gravadas + agenda
- Marketplace: contratação direta + take rate
- Matchmaker: IA sugere mentor a partir do mapa
- Eventos (A Origem / Semana) com mentores da base no centro

Portões sugeridos

- Semana 2 do piloto: ≥70% fazem 3 sessões
- D30: retenção > 60%
- Domínio médio +20 pts vs baseline
- NPS > 60 antes de escalar aquisição paga
- Mentoria: ≥X% dos alunos ativos recebem match; conversão match→contratação; take rate estável
- Conteúdo vivo: % gaps resolvidos por reuso > criação nova após N semanas; tempo médio gap→publicado; taxa de rejeição na curadoria

---

9. Escada comercial (sem confundir SKUs)

Oferta | O que entrega | Quem monetiza

— Peptídeos (grátis) · Porta de entrada + hábito light · Doutiva (funil)

— Protocolos (R$ 297/mês) · Mapa + Caso do Dia + Universidade + Preceptor · Doutiva (assinatura)

— Aulas do mentor · Conteúdo gravado do médico na plataforma · Mentor (+ eventualmente split) / Doutiva

— Mentoria (1:1 ou turma) · Proximidade humana sob demanda · Mentor + take rate Doutiva

— Imersão / Eventos · Proximidade presencial + marca · Doutiva (+ mentores no palco)

— Clube · Círculo restrito / conselho · Doutiva

IA e hábito vivem em Protocolos. Mentoria marketplace e eventos são proximidade + comunidade — SKUs separados do hábito diário. O take rate da mentoria é a segunda perna de receita (além da assinatura): escala com a comunidade, não só com o CAC de aluno.

---

10. O que NÃO fazer

- Chatbot aberto sem corpus Doutiva (“cheatbot”)
- Empurrar ementa linear para quem já domina o tema

- Fazer o mentor virar Duolingo
- Fundir mentoria dentro do curso e perder o SKU / o take rate
- Ter vitrine de mentores sem aulas / perfil / agenda (só lista decorativa)
- Deixar a IA “substituir” o mentor em vez de indicar o mentor
- Criar aula nova a cada gap sem buscar o que já existe (explode o catálogo)
- Publicar criação da IA sem curadoria / assinatura humana
- Medir sucesso só por aulas concluídas / horas publicadas (ignorar GMV mentoria, retenção de mentores e reuso de conteúdo gerado)
- Abrir para médico pagante sem Mapa + IA ligada + proximidade mínima no piloto

---

11. Pedido de análise ao Claude

Por favor, avalie criticamente:

- A arquitetura Caso do Dia / Curso / Mentores-comunidade / Eventos / Mapa-IA está coerente para EMC de médicos em prática no Brasil?
- O desenho do cérebro (Cartógrafo / Preceptor / Bibliotecário / Estúdio / Matchmaker) — em especial o loop recuperar-ou-criar-persistir — é suficiente para “IA no centro / ser vivo”, ou falta alguma camada?
- Como priorizar as Fases A–D se o objetivo é: (a) retenção, (b) gerar demanda para o consultório, (c) comunidade de mentores, (d) autopopulação inteligente do catálogo?
- O modelo marketplace de mentoria com take rate fortalece ou dilui a marca Doutiva? Qual take rate / regras de qualidade sugerir no início?
- Como a IA deve ranquear mentores sem virar caixa-preta injusta?
- Quais regras de curadoria (limiar de demanda, dedupe, rascunho vs. publicado, temas que exigem CRM) você recomenda para o Estúdio não poluir a escola?
- Quais riscos regulatórios/éticos (CFM, propaganda, conteúdo gerado por IA e do mentor) precisam de guarda-corpo explícito?
- Proponha um MVP de 30 dias ainda mais enxuto, se discordar da ordem acima.
- Sugira métricas de piloto e “go / no-go” para Protocolos, marketplace de mentores e o loop de criação de conteúdo.---

12. Referências internas desta conversa

- Avaliação da plataforma (06/11/2026)
- Benchmark *Precursores do ensino com IA no mundo* (07/11/2026) — Alpha, Khanmigo, Duolingo, Brilliant, AMBOSS/NEJM Knowledge+, Arist/WhatsApp
- Plano 90 dias: `docs/plano-tutor-maestria-90-dias.md`
- Norte de cópia: AMBOSS (produto) × Medway (confiança) × MasterClass (marca) × Duolingo (hábito)

Fim da síntese. Documento preparado para revisão crítica e refinamento do plano de execução.